

AERIS NOTFALLKARTEN-SET

SOP-Karten für die Notfalltasche im 1:1 AKI-Setting (§ 132l SGB V)

INHABER: RENÉ KRIEG

Examinierter Pflegefachmann

AKI | Beatmungstherapeut | Pain Nurse | ICW®

NOTFALLKARTE 1 | RESPIRATORISCHE & KANÜLEN-NOTFÄLLE

AERIS 1:1 AKI NOTFALL-SOP

KONTROLL- & ALARMINDIKATOREN

- **SpO₂-Abfall (< 90%)**: Zyanose, Unruhe, Kaltschweißigkeit, Dyspnoe.
- **Druckalarm Respirator**: Paw > 40 mbar (Obstruktion/Knick) oder PEEP-Verlust (Dislokation/Cuff-Leckage).
- **Sekretstau**: Borkenbildung, zähes Sekret, fehlendes Atemgeräusch.

SOFORTMASSNAHMEN / SOP

- **1. Manuelle Beutlung**: Respirator entkoppeln, Beutel mit 100% O₂ (15 l/min) anschließen & Beutlung starten.
- **2. Endotracheales Absaugen**: Aseptisch absaugen (max. -0,2 bar, max. 10 Sek., passende Kathetergröße).
- **3. Cuff-Kontrolle**: Cuffdruck mittels Ruhedruckmesser prüfen (optimal: 20–25 mmHg).

KANÜLEN-DISLOKATION / KRISTALLSOP

- **Teildislokation**: Entblocken, vorsichtig nachführen, reblocken, Auskultation, Fixierung prüfen.
- **Vollständige Dislokation**: Spreizer/Trousseau-Set nutzen, Ersatzkanüle (gleiche Größe) sofort einführen.
- **Notfall-Alternative**: Bei Obstruktion Notfall-Ersatzkanüle 1 Größe kleiner nutzen!

TECHNIK- & STROMAUSFALL

- **Respirator-Ausfall**: Sofort manuelle Beutlung beibehalten!
- **Akku-Notbetrieb**: Interne Akkulaufzeit prüfen, Umschaltung auf Notstromsteckdose (grün).
- **Technik-Meldung**: Medizintechnik-Hotline & B2B-Springer benachrichtigen.

NOTFALLKARTE 2 | KARDIOVASKULÄRE & MEDIZINISCHE AKUTNOTFÄLLE

AERIS 1:1 AKI NOTFALL-SOP

HERZ-KREISLAUF-STILLSTAND

- **Indikatoren**: Bewusstlosigkeit, Pulslosigkeit, Schnappatmung.
- **DNR / Patientenverfügung (§ 1827 BGB)**: SOFORT Prüfen! Liegt DNR (Do Not Resuscitate) vor?
- **CPR-Einleitung**: Falls KEIN DNR vorliegt: Thoraxkompression (30:2) unter manueller Beutlung über Trachealkanüle.

SCHOCK & VITALFUNKTIONSKRISEN

- **Septischer Schock**: Fiebersturm/Unterkühlung, RR-Abfall, Tachykardie, Marmorierung.
- **Anaphylaxie / Reaktion**: Schwellung, Urtikaria, akuter SpO₂-Abfall.
- **Erstmaßnahme**: Flachlagerung (bei Dyspnoe Oberkörper hoch), O₂-Gabe erhöhen, Notruf 112.

NOTRUF-MELDERSCHEMA (112)

- **WO**: Adresse des Klienten (siehe Stammblatt im Ordner)
- **WAS**: Tracheotomierter / Beatmeter Intensivpatient in Akutkrise!
- **WIE VIELE / WELCHE**: Notarzt & Rettungswagen mit Intensivmedikation anfordern.
- **WARTEN**: Auf Rückfragen der Leitstelle warten!

MEDIZINISCHE TELEFONKETTE

- **Notruf Rettungsdienst**: 112
- **Behandelnder Pneumologe**: [Telefonnummer aus Stammblatt]
- **Hausarzt**: [Telefonnummer aus Stammblatt]
- **SAPV-Notfallhotline**: [24/7 Telefonnummer]

AERIS NOTFALLKARTEN-SET (FORTSETZUNG)

NOTFALLKARTE 3 | SCHMERZ- & SYMPTOMKRISEN (PAIN NURSE / SAPV)

AERIS 1:1 AKI NOTFALL-SOP

REFRAKTÄRE ATEMNOT & PANIK

- **Symptome:** Kaltschweißigkeit, Tachypnoe, Beatmungs-Asynchronität, Angst.
- **Ausschlussmechanismus:** Zuerst Verstopfung/Absaugbedarf & Respiratordefekt ausschließen!
- **Deeskalation:** Ruhiger Blickkontakt, synchrone Atemunterstützung, Oberkörperhochlagerung (135°).

SCHMERZSTURM & DELIR-ASSESSMENT

- **Kommunizierende Klienten:** NRS (Numerische Rating-Skala 0–10).
- **Non-verbale / Beatmete Klienten:** BESD-Skala (Beobachtung von Schmerz bei Demenz/Intensivpatienten).
- **Indikatoren:** Stirnrunzeln, Abwehrspannung, Anstieg von Heart Rate & Blutdruck.

BEDARFSMEDIKATION (PAIN NURSE)

- **Anordnungsbogen:** Gabe der bedarfsärztlich verordneten Analgetika / Anxiolytika nach Plan.
- **Dokumentation:** Exakte Erfassung von Dosis, Applikationszeit und Re-Evaluation nach 30 Min. in Doku-Suite.
- **Arzt-Rücksprache:** Bei persistierendem Schmerz (> NRS 4) unverzügliche Arztverständigung.

SAPV-EINBINDUNG (§ 37B SGB V)

- **Kontakt:** Aktivierung des spezialisierten Palliative-Care-Teams bei krisenhafter Symptomprogredienz.
- **Entlastung:** Vermeidung unnötiger Krankenhauseinweisungen am Lebensende im Klientenwillen.
- **24/7 Rufbereitschaft:** Kontaktdaten im Klientenordner unter TAB 2.

NOTFALLKARTE 4 | PERSONALAUSFALL & LOGISTIK-KASKADE

AERIS 1:1 AKI NOTFALL-SOP

AKUT AUSFALL IM 1:1-SETTING

- **Szenario:** Krankmeldung der Fachkraft kurz vor Schichtbeginn (z. B. 05:30 Uhr).
- **Meldepflicht:** Unverzügliche Benachrichtigung von René Krieg (AERIS Einsatzleitung).
- **Sicherheit:** Die laufende Schicht darf das Pflegebett erst verlassen, wenn Ersatz vor Ort ist!

3-STUFIGE AUSFALLKASKADE

- **STUFE 1 (Tandem):** Aktivierung der fest eingearbeiteten Tandem-Partnerkraft (Cross-Einarbeitung).
- **STUFE 2 (Angehörige):** Greifen des Notfallpuffers (geschulte Angehörige überbrücken 2–4 Std.).
- **STUFE 3 (Springer):** Einsatzfreigabe für das B2B-Springer-Netzwerk von AERIS.

STANDBY & KLINIKAUFENTHALT (§ 615 BGB)

- **Klinikaufnahme Klient:** Sofortige Standby-Meldung an Ausfallvertretung & Kostenträger.
- **Schadensminderungspflicht:** Anbieten der freigewordenen Arbeitskapazität als Springer an Dritte.
- **10-Tage-Regelung:** Vorhaltepauschale 80 % (76,00 €/Std.) für max. 10 Tage.

AERIS EMERGENCY HOTLINES

- **AERIS Geschäftsleitung (René Krieg):** 0170 / [Mobilnummer]
- **Tandem-Partnerkraft:** [Name & Nummer aus Tandem-Vereinbarung]
- **Angehörigen-Notfallpuffer:** [Name & Nummer aus Stammblatt]
- **AERIS B2B-Springer-Hotline:** 24/7 Rufbereitschaft